

CAPÍTULO 9.2

Perfil de Hierro

PERFIL EUNACOM 1.071.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Perfil de Hierro (Perfil de Fierro)

Parámetros y valores normales

TABLA 9.2.1: PARÁMETRO VS VALOR NORMAL		
PARÁMETRO	VALOR NORMAL	QUÉ REFLEJA
Ferritina	30–200 ng/mL	Depósitos de hierro; también reactante de fase aguda (+)
Transferrina / TIBC	215–370 mg/dL	Transporte de hierro; reactante de fase aguda (–)
Saturación de transferrina	20–50%	Hierro disponible en circulación
Ferremia	Variable	Poco útil clínicamente

EUNACOM CRITERIOS

Ferritina = reactante de fase aguda positivo → sube en inflamación aunque no haya sobrecarga de hierro. No confundir ferritina alta con depósitos altos si hay inflamación.

- **Artritis + ferritina muy ↑↑** → sospechar **enfermedad de Still (Artritis Reumatoide: Clínica y Diagnóstico)** [artritis reumatoide del adulto)

Talasemia y Perfil de Hierro

- Puede ser normal o mostrar patrón de sobrecarga de hierro
- En formas transfusión-dependientes: riesgo de **hemocromatosis secundaria**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 65 años en estudio de anemia presenta: Ferritina 14 ng/mL, Sideremia 28 mcg/dL, TIBC 420 mcg/dL y Saturación de Transferrina (IST) 8%. RDW/ADE 17.5%."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Perfil de Hierro Típico de Ferropenia: la Ferritina < 30 ng/mL es el parámetro más sensible y específico de ferropenia verdadera (depósitos agotados). Cursa con TIBC elevada, Sideremia baja, IST < 20% y RDW elevado (anisocitosis).

Patrones por Patología

TABLA 9.2.2: PATOLOGÍA VS FERRITINA			
PATOLOGÍA	FERRITINA	TRANSFERRINA/TIBC	SATURACIÓN
Ferropenia	↓ (baja)	↑ (alta)	↓ (baja)
Anemia: Generalidades	Anemia enf. crónica	↑ (reactante)	↓
Hemocromatosis	↑↑ (muy alta)	↓	↑ (alta)
Talasemia	Normal o ↑	Normal o ↓	Normal o ↑

Casos clínicos tipo

- **Anemia + ferritina ↓** → anemia **ferropénica**
- **Hepatitis + ferritina ↑** → reactante de fase aguda (no es hemocromatosis)
- **Daño hepático crónico + ferritina muy ↑** → sospechar **hemocromatosis**

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La ferritina (normal 30-200 ng/mL) es el parámetro más importante del perfil de hierro y refleja los depósitos de hierro
- La ferritina es un reactante de fase aguda que se eleva con cualquier causa de inflamación
- La transferrina es un reactante de fase aguda negativo que baja con la inflamación y sube en ferropenia
- La saturación de transferrina normal es 20-50%, baja en ferropenia y sube en sobrecarga de hierro
- La ferremia tiene poca utilidad clínica porque no diferencia bien las causas de anemia
- En ferropenia: ferritina baja, transferrina alta, saturación baja
- En enfermedad crónica: ferritina alta, transferrina baja
- Ferritina muy elevada + daño hepático crónico sugiere hemocromatosis
- Ferritina muy elevada + artritis sugiere enfermedad de Still del adulto
- Las talasemias pueden tener perfil de hierro normal o con sobrecarga de hierro (hemocromatosis secundaria)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PERFIL DE HIERRO)

PREGUNTA 1

Paciente con anemia normocítica, ferritina de 450 ng/mL y transferrina baja. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Anemia ferropénica
- ☐ B) Anemia por enfermedades crónicas
- ☐ C) Hemocromatosis
- ☐ D) Talasemia
- ☐ E) Déficit de vitamina B12

PREGUNTA 2

¿Cuál de los siguientes parámetros del perfil de hierro es un reactante de fase aguda negativo?

- ☐ A) Ferritina
- ☐ B) Ferremia
- ☐ C) Transferrina
- ☐ D) Saturación de transferrina
- ☐ E) Hemoglobina

PREGUNTA 3

Paciente con artritis de larga data, ferritina de 5.000 ng/mL y fiebre. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más específica?

- ☐ A) Artritis reumatoide
- ☐ B) Lupus eritematoso sistémico
- ☐ C) Enfermedad de Still del adulto
- ☐ D) Hemocromatosis
- ☐ E) Hepatitis autoinmune

RESUMEN: PERFIL DE HIERRO

Esta clase aborda el perfil de hierro (o perfil de fierro), detallando cada uno de sus componentes y su interpretación clínica. La ferritina es el parámetro más importante, con valor normal de 30-200 ng/mL, refleja los depósitos de hierro y es un reactante de fase aguda. Se explica que con el hemograma más la ferritina, en la mayoría de los casos ya se orienta fuertemente al diagnóstico. La transferrina refleja el transporte de hierro, se eleva en ferropenia y baja con la inflamación (reactante de fase aguda negativo). La TIBC es muy similar a la transferrina. La saturación de transferrina (normal 20-50%) baja en ferropenia y aumenta en sobrecarga de hierro. La ferremia tiene poca utilidad clínica porque no diferencia bien las causas de anemia. Se revisan los patrones del perfil de hierro en las principales patologías: ferropenia (ferritina baja, transferrina alta, saturación baja), enfermedad crónica (ferritina alta, transferrina baja), hemocromatosis (ferritina muy elevada, saturación alta) y talasemias (perfil normal o con sobrecarga de hierro).